



皮肤抓搔症（抓痕症）

作者：[Katharine Anne Phillips](#), MD, Weill Cornell Medical College;

[Dan J. Stein](#), MD, PhD, University of Cape Town

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 11月 2025 | 修改的 1月 2026

皮肤抓搔症是指患者反复抓搔自己的皮肤，导致皮肤受损。

- 皮肤抓搔症患者在抓搔前可能有紧张或焦虑感，而抓搔皮肤可以缓解这些情绪。
- 当患者过度抓搔皮肤而造成损伤、试图减少或停止抓搔皮肤但做不到、因此非常痛苦或功能受损时，医生会诊断该疾病。
- 专门针对皮肤抓搔症的认知行为治疗（习惯消除治疗）、某些抗抑郁药物或 N-乙酰半胱氨酸或美金刚可帮助减轻症状。

此病患者会反复地抓搔或刮擦自己的皮肤。他们这样做不是为了去除他们认为不美观或患病的皮肤斑点或瑕疵（就像[躯体变形障碍](#)患者那样）。有些患者抓搔健康的皮肤。有些则抓搔皮肤硬结、粉刺或结痂。

皮肤抓搔症通常在青春期发病，但也可在其他年龄发病。任何时候，约有 2% 至 3% 的人患有此病。约有 60% 至 75% 的患者为女性。

皮肤抓搔症的症状

抓搔方法和抓搔部位因人而异。有些患者的抓搔创口或瘢痕很多。有些则仅有几个瘢痕或创口。患者的抓搔部位也会随时间发生改变。

有些人可能是不由自主地去抓搔皮肤，没有去想。有些则更为有意识地去抓搔。

患者并非因为担忧自己的外表而抓搔皮肤（[躯体变形障碍](#)可能会有症状）。但是，他们在抓搔前可能有紧张或焦虑感，而抓搔皮肤可以缓解这些情绪。之后，他们通常会感到满足。

皮肤抓搔可能会伴随很多其他活动（仪式）。患者可能会煞费苦心地寻找要抓搔的特定结痂。他们可能会采用特定的方式抓掉痂皮——例如，用手指或镊子等工具。痂皮一旦抓掉后，他们可能会咬噬或吞掉痂皮。

许多皮肤抓搔症患者也会反复拔掉毛发、咬指甲、咀嚼面颊或做其他[重复性的身体关注性动作](#)。有些患者抓搔其他人的皮肤。

患者可能会因不能控制自己的行为而感到尴尬或羞耻。因此，他们可能会躲避其他人能够看到其皮肤损伤的情形。他们通常不在外人面前抓搔皮肤，家人除外。很多患者尝试通过衣服或化妆掩盖皮肤损伤。他们可能也会因自己的失控而感到痛苦，并反复尝试停止或减少抓搔皮肤，但却做不到。

如果过度抓搔皮肤，可导致瘢痕、感染、过度出血，甚至严重的血流感染（[脓毒症](#)）。

许多皮肤抓搔症患者还有其他精神疾病，如[专注身体的重复行为障碍](#)、[强迫症](#)、[拔毛癖](#)和[抑郁](#)。

症状的严重程度通常不固定，但可持续终生。

皮肤抓搔症的诊断

- 医生根据特定精神病诊断标准进行评估
- 体格检查，有时需要进行医学检查，以评估躯体疾病

医生根据以下症状诊断皮肤抓搔症：

- 过度抓搔皮肤，导致皮肤受损
- 反复尝试减少或停止抓搔
- 因皮肤抓搔症感到极大的痛苦或功能受到损害

皮肤抓搔不能由毒品引起，如可卡因；药物，如兴奋剂；或其他疾病，如疥疮。

皮肤抓搔症的治疗

- 认知行为疗法（特别是习惯逆转治疗）
- 药物，包括 N-乙酰半胱氨酸或美金刚

专门针对皮肤抓搔症的[认知行为治疗](#)，特别是习惯逆转治疗，是首选治疗。习惯消除治疗会教患者做以下事情：

- 更多地意识到他们的皮肤抓搔行为
- 识别触发该行为的情境
- 使用策略帮助他们阻止自己抓搔皮肤——例如，从抓搔皮肤改为不同的活动（例如握紧拳头、编织或坐在自己手上）

N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 和美金刚均作用于谷氨酸能系统，并可帮助减少皮肤抓搔。使用[选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂](#)（一种抗抑郁药）或氯丙咪嗪治疗也可能有效，并可能改善任何共存[抑郁](#)或[焦虑障碍](#)的症状。有限的证据表明这些药物也可减少皮肤抓搔。